

Anamnèse et examen gynécologiques

Table des matières

1) Douleur mammaire.....	1
1.1) Anamnèse.....	1
1.2) Status.....	1
2) Examen gynécologique.....	3

1) Douleur mammaire

1.1) Anamnèse

- Caractérisation de la plainte en 7 points + les bonus
- Écoulement depuis les aréoles
- Cycle menstruel : anomalies de durée, régularité, contraception, grossesse. Perte, type, durée, quantité
- Antécédents familiaux de cancer du sein
- Tabac et alcool
- Demander (et recommander !) les auto-examens (idéalement au début du mois et tous les 2 cycles)

1.2) Status

Inspection :

- Demander à la patiente d'enlever son soutien-gorge, de s'asseoir sur la table les bras ballants
- Observation de la cage thoracique : une déformation de la cage thoracique peut provoquer une asymétrie des seins et expliquer le problème de la patiente
- Peau
- Mamelon et aréole
- Poser ses mains derrière la nuque (= position à la plage) et gonfler le torse
- Poser ses mains sur les cuisses et gonfler le torse
- Mêmes examens, mais cette fois-ci en position couchée

Palpation des seins :

- Commencer par se souvenir que le sein est un organe hormono-dépendant et qu'il faut idéalement l'examiner dans le premier tiers suivant le cycle menstruel. Plus tard l'influence des oestrogènes va augmenter la perméabilité capillaire, provoquant un oedème tissulaire interstitiel qui rend la palpation plus difficile. En fin de cycle, le sein est tendu, particulièrement sensible voir même parfois douloureux, ce qui est désagréable pour la

patiente et ne permet pas un retour d'information fiable

- Palpation assise ; cette position permet de bien dégager les deux quadrants supérieurs des seins
 - De la pulpe de ses 3 doigts du milieu, faire des trajets verticaux partant depuis la clavicule jusqu'au sein. Palper en fin de course vers l'aréole. Continuer les « caresses » des 3 doigts sur les parties latérales des seins.
On notera que les tumeurs du seins se situent dans le quadrant supéro-externe (prolongement axillaire compris) dans 2/3 des cas
- Palpation couchée ; cette position permet de répartir le sein à plat
 - Palper en pianotant la clavicule, le sternum, une ligne horizontale située 1cm sous le sein et la ligne axillaire antérieure
 - Même technique de palpation que pour la palpation assise, cette fois-ci de manière centripète
(Il est conseillé de palper l'hémisphère des deux seins situé à l'opposé du côté où on se trouve par rapport à la patiente)
 - Autre technique : on demande à la patiente d'étendre ses bras au-dessus de sa tête et on tire des traits verticaux et horizontaux sur le sein. On commence par se déplacer horizontalement, de l'extérieur vers l'intérieur, du haut vers le bas ; on suit ensuite les lignes verticales du haut vers le bas, de l'extérieur vers l'intérieur
- Recherche d'un écoulement : à la fin de l'examen, on avertit la patiente et on compresse le mamelon pour rechercher la présence d'un écoulement (la patiente peut également le faire elle-même). Si un écoulement sort, le prendre sur une lame cytologique.
En cas d'écoulement, évaluer quel canal galactophore s'est vidé en répétant la palpation radiaire des seins, la patiente étant couchée. On fera ensuite une galactographie ou une échographie.
Les cancers font très rarement des écoulements (2%), et ceux le faisant (papillomes et ectasies canalaire) sont bénins
- Un nodule est presque toujours suspect, mais peut naturellement apparaître dans la phase pré-menstruelle. Il faut donner sa localisation (donner l'heure où il se trouve + sa distance par rapport au mamelon), taille, forme, consistance, délimitation, mobilité et sensibilité

Palpation des ganglions lymphatiques :

- Inspecter la peau péri-claviculaire et axillaire
- Palper les ganglions péri-claviculaires en pianotant (on peut lui demander d'incliner la tête du côté ipsilatéral à la palpation pour relâcher le SCM)
- Palper les ganglions axillaires en position assise : demander de mettre les mains sur les hanches, sans exercer de pression, pour bien relaxer la musculature des creux axillaires ; on peut aussi lui demander de nous agripper l'épaule. On pianote ensuite et on palpe. On peut demander à la patiente de gentiment presser sur ses hanches pour tendre les m. grands pectoraux pour mieux palper la région derrière ces mm.
- Palper les ganglions axillaires en position couchée en pianotant et palpant

2) Examen gynécologique

Examen abdominal:

- Faire une palpation abdominale comme dans l'examen abdominal
- Palper les ganglions inguinaux

Inspection des organes génitaux externes :

- Mettre des gants en latex ou autre si allergie ou préférence
- Pilosité et peau des régions pubienne, inguinales et du périnée (avec ses régions uro-génitale et anale). En cas de démangeaisons, penser aux pouls du pubis et aux morpions, mais aussi à la galle (si dans les plis)
- Extérieur de la vulve¹ : mont de Vénus, grandes lèvres, petites lèvres, clitoris et vestibule (cf. plus bas). Rougeur, taille, pigmentation, etc.
- Vestibule au repos : c'est l'espace entre le clitoris et la commissure postérieure, circonscrit par les petites lèvres. Il contient le méat urétral et ses glandes para-urétrales, ainsi que les orifices vaginal et des deux glandes de Bartholin (cachées sous les grandes lèvres).
On écarte les petites et grandes lèvres du côté du ventre pour pouvoir inspecter le clitoris (N < 3-4mm), les petites lèvres (souvent asymétriques et avec pigmentation différente)², le méat urinaire (saillie fréquente chez les patientes post-ménopausiques ; on peut alors s'assurer par biopsie qu'on a affaire à une caroncule urétrale et non une tumeur maligne) et l'ouverture du vagin.
On peut ensuite écarter les grandes et petites lèvres du côté du sacrum pour mieux entrevoir l'orifice vaginal ; on peut alors parfois retrouver des restes de l'hymen, les caroncules, qui peuvent être douloureux et saigner. Rechercher un écoulement anormal et des cicatrices d'épisiotomie dans la région de la commissure postérieure
- Vestibule sous pression intra-abdominale : écarter les grandes lèvres du côté sacré de deux mains et demander à la femme de pousser comme pour aller à selles. On recherche surtout des hernies et prolapsus (antérieur avec vessie et urètre (= uréthro-cystocèle), moyen avec utérus et vagin (= prolapsus utérin) et postérieur avec intestins (= entéro-cèle) et rectum (= rectocèle))
- Inspection de la région anale : fissures, fistules, rougeurs, hémorroïdes, etc.

Palpation³ :

- Glandes para-urétrales : palpées en cas de suspicion d'urétrite, elles sont situées des deux côtés de l'urètre. On introduit gentiment les deux phalanges (car elles vont très loin !) de l'index dans le vagin, la paume vers le ciel, puis gentiment imprimer une pression sur le toit du vagin tout en retirant son doigt. On recherche une douleur et/ou un écoulement du méat urétral ou de son pourtour
- Glandes de Bartholin/vulvo-vaginales : on introduit l'index (gauche si on teste la gauche, droit si on teste la droite) dans le vagin de la patiente et on pince ses grandes lèvres avec le

1 Terme technique pour désigner l'ensemble des organes génitaux externes des femmes

2 Les petites lèvres sont parfois parsemées de papules blanc-jaunâtre ; ces papules sont des glandes sébacées ectopiques, ni symptomatiques, ni pathologiques

3 À partir de maintenant, il est important de toujours annoncer tout ce que l'on fait !

pouce à l'extérieur. Faire rouler la peau entre ses deux doigts à la recherche d'une zone douloureuse ou un écoulement. Normalement, rien ne devrait être palpé

Examen au spéculum :

- Introduction du spéculum : mettre un peu de lubrifiant sur le bout du spéculum, écarter les grandes et petites lèvres d'une main, tenir le spéculum comme un pistolet, l'index et le majeur pinçant son « bec », puis l'introduire en le tenant comme les gangstas tiennent leurs pistolets (= entre 45° et 90°), en pressant légèrement sur la paroi postérieure du vagin (= le reposer contre la commissure postérieure). Pendant qu'il entre dans le vagin, gentiment le tourner et l'ouvrir pour voir le col de l'utérus. Fixer la vis.
Si la patiente est crispée, on peut lui demander de pousser contre le spéculum. Si l'utérus est rétroversé, le col est plus antérieur, donc il faudra un peu manoeuvrer une fois dans le vagin
- Col de l'utérus : position, axe, forme, diamètre, texture, qualité, couleur, ouverture. Normalement, c'est un rond presque parfait de 2,5cm de diamètre, dépassant de près de 3cm du fond du vagin. L'ouverture est souvent ronde chez les nullipares et ovale ou en fente chez les primi- et multipares.
On peut parfois retrouver des kystes de Naboth, qui sont des oblitérations des glandes de la muqueuse du col. Ces kystes sont asymptomatiques et ne doivent être traités que s'ils gênent la patiente.
- Prélèvements : on effectuera un prélèvement en cas d'écoulement, de douleurs brûlantes ou de prurit génital. Pour le faire, une fois en position avec le spéculum, introduire la spatule d'Ayre dans le vagin, l'apposer contre le col et faire un tour complet en contact avec le col. On dépose ensuite le matériel sur une lame en ajoutant une goutte de NaCl ; si on suspecte une mycose, ajouter une autre lame avec une goutte de KOH ; en présence de pus, demander un Gram supplémentaire
- Retirer le spéculum : on commence par dévisser la vis tout en maintenant le vagin ouvert, puis on retire le spéculum lentement pour observer les parois antérieure et postérieure, le spéculum étant tourné de 45° à 90°. Avant de sortir du vagin, on revient à la position neutre, on le garde toujours un peu ouvert (évite de pincer l'intérieur du vagin de la patiente !), puis on le retire dans l'axe du vagin

Palpation vaginale bimanuelle :

- En étant debout, on introduit l'index et le majeur de la main dominante dans le vagin (évidemment avec des gants) comme un spéculum, c'est-à-dire qu'on commence par écarter la partie sacrée du vagin d'une main, et que l'autre est positionné comme si on faisait un pistolet (entre 0° et 45°) avec pour l'entrée, en reposant son majeur contre la commissure postérieure, puis une fois à l'intérieur pivoter la main pour commencer la palpation vaginale
- Vagin : on pivote les doigts à la recherche de nodules, tumeurs, cicatrices, points douloureux ou selles dans le rectum. Pour palper le cul-de-sac rétro-utérin, on oriente sa paume vers le haut, puis on met ses doigts sous le col, dans le cul-de-sac vaginal postérieur
- Col : position (normalement dans l'axe), sa consistance (mou, ferme, nodulaire ou friable), contours, mobilité (N 2cm à 4cm), douleur. Un col dur, douloureux, avec des contours irréguliers et une mobilité réduite doit évoquer un cancer. Un col peu mobilisable avec douleur à la palpation des annexes doit évoquer une inflammation pelvienne

- Utérus : c'est le début de l'examen bimanuel : on commence par placer sa main dans le vagin dans le cul-de-sac vaginal postérieur comme décrit précédemment, l'autre main palpant depuis la surface du ventre, à mi-distance entre la symphyse et l'ombilic. On fait ainsi une pince avec les deux mains. La main vaginale explore la face postérieure et la base de l'utérus ainsi que les paramètres (= face inférieure du ligament large) ; elle peut explorer la face antérieure de l'utérus en la mettant dans le cul-de-sac vaginal antérieur.
On évalue la taille, la forme, la consistance et la mobilité (augmente en cas d'accouchements) de l'utérus.
Il faut aussi garder en tête que l'utérus n'est pas toujours palpable avec cette méthode, surtout chez les patients obèses ou très musclées. L'utérus peut aussi être rétro-versé, auquel cas une palpation rectale permettra de le sentir
- Annexes : palpation identique à celle de l'utérus, en positionnant cette fois-ci les doigts de la main vaginale dans le cul-de-sac latéral. Les ovaires font une taille proche de celle d'une noix (3,5cm x 2cm x 1,5cm) et sont toujours sensibles à la palpation (mais pas douloureux !). Là encore, on décrit leur taille, forme, consistance et mobilité.
On ne palpe souvent que les ovaires pour cette palpation, et parfois rien du tout comme pour l'utérus. On notera que les ovaires s'atrophient après la ménopause, ils ne devraient plus être palpables après 3 à 5 ans ; si c'est le cas, évoquer un kyste ou une tumeur

Palpation recto-vaginale :

- On remet la main vaginale dans la position pour mimer un pistolet (= entre 0 et 45°). En gardant l'index dans le vagin, retirer le majeur puis lentement l'introduire dans l'anus tout en demandant à la patiente de pousser (permet de relâcher le sphincter). Mettre 2 phalanges suffit
- Palper la cloison recto-vaginale (épaisseur, tumeur, nodule, douleurs)
- Terminer par un TR simple, avec l'index. Pour ce faire, on demande une nouvelle fois à la patiente de pousser pour relâcher les sphincters, on introduit maximum deux phalanges dans le rectum et on pivote pour examiner tout son pourtour. On examine également le cul-de-sac vaginal postérieur et la face postérieure du col utérin